PLANO DE ANÚNCIOS PARA CONSULTÓRIO · VERSÃO DE 04/11/2026

Como eu faria seus anúncios de Gastroenterologia

Plano para quem tem consultório próprio, continuando o carrossel: a conta, a verba, as campanhas, os criativos e o combinado com a recepção, para gastroenterologia.

1 A conta da consulta, antes de qualquer anúncio

Clínica não compra conversa. Clínica compra paciente sentado na cadeira. Por isso a primeira coisa que eu faria é esta conta, com os seus números.

1 O valor da consulta que você cobra

2 menos o que ela custa para você (equipe, aluguel, imposto) = o que sobra

3 Valor da consulta ÷ o que sobra = quanto cada R$ 1 de anúncio precisa voltar para empatar

EXEMPLO, NÃO É NÚMERO SEU

Consulta de R$ 400, sobram R$ 200	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 2**
Com 25% de desconto: consulta de R$ 300, sobram R$ 100	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 3**
R$ 1.000 de verba a R$ 10 por conversa = 100 conversas	**16 consultas realizadas, R$ 6.400 em consultas de R$ 400 (se 40% agendam e 40% comparecem)**

Seus números: consulta R$ _____ · sobra R$ _____ · cada R$ 1 precisa voltar R$ _____

Os 40% são benchmark de mercado (funil 40/40/40, do método de Pedro Sobral): de 100 conversas, 40 agendam, 16 comparecem e 4 fecham tratamento ou procedimento. Serve só para abrir a conversa. Com 60 a 90 dias de campanha, vale o número da sua conta, e só ele.

O que entra na conta nesta especialidade

Em gastro, o exame (endoscopia, colonoscopia) pode valer mais que a consulta. Conte o exame só se você o realiza no seu serviço. Se encaminha, a conta é a consulta e o retorno. Considere também o preparo, que se não for bem explicado vira falta.

2 Onde colocar a verba

Google
vai quem tem urgência. O paciente já está procurando e escolhe quem aparece e responde primeiro.

Meta (Instagram e Facebook)
vai quem tem ticket e precisa de confiança. Antes de vender o preço, eu preciso vender o médico.

Notoriedade
médico já conhecido na cidade rende no Google mesmo com ticket alto.

COMBO: GOOGLE FORTE NO SINTOMA

Azia, refluxo e dor de barriga que não passa viram busca no Google na hora do incômodo. O check-up, como a endoscopia e a colonoscopia, é decisão de adulto que adia e precisa de confiança. Google para o sintoma de agora. Meta para lembrar o check-up e explicar o exame sem susto.

A fatia exata de cada lado eu só fecho com 60 a 90 dias de dado da sua conta. Aqui está o ponto de partida.

3 As 3 campanhas do Google

Volume de busca e custo por clique eu não medi para a sua cidade. Tudo abaixo é para testar, não é dado. Eu começaria em correspondência exata, e abriria para frase só se a exata não gastar a verba.

1. Nome do médico

Quem já ouviu falar de você e vai conferir. Teto de R$ 30 por dia.

- dr. / dra. [seu nome]
- [seu nome] [cidade]
- [nome da clínica] [cidade]

2. Especialidade + cidade

Quem já sabe qual médico procura e está comparando.

- gastroenterologista [cidade]
- gastroenterologista particular [cidade]
- consulta com gastroenterologista [cidade]
- endoscopia [cidade]
- colonoscopia [cidade]
- gastro [cidade]

3. Sintoma

Quem ainda não sabe qual médico resolve. Ele pesquisa o que sente.

- azia todo dia
- refluxo que não passa
- dor na boca do estômago
- barriga inchada depois de comer
- gases e prisão de ventre
- diarreia que não melhora
- queimação no estômago

Negativar de saída: "chá", "dieta", "remédio caseiro", "receita", "grátis", "SUS".

> Anuncie endoscopia e colonoscopia só se você as realiza. Quem busca o exame quer saber onde fazer, o preço e o preparo. Ponha os três na página de destino.

Destino do clique: o WhatsApp da recepção ou uma página curta com preço, forma de pagamento e endereço. O clique no botão de WhatsApp é a conversão que eu marco.

4 Público e sequência na Meta

Público

Adultos da cidade e do raio. O criativo fala com quem convive com azia ou intestino irregular e tem vergonha de falar disso. Um anúncio por queixa, e um para o check-up de quem não sente nada.

MÊS 1

70% no topo

70% da verba vai para quem ainda não conhece o seu nome, com vídeo que tira dúvida. Os 30% restantes vão para o anúncio de consulta, com preço e forma de pagamento, para quem já viu o vídeo.

Os dois primeiros vídeos do mês são a azia que volta todo dia e o que acontece numa endoscopia, passo a passo.

MÊS 2 EM DIANTE

60% em remarketing

60% da verba vai para quem já conhece você: quem chamou no WhatsApp (180 dias), quem visitou o site (90 dias) e quem assistiu aos vídeos (30 dias). O topo continua rodando com o resto.

Quem chamou e não marcou vê o vídeo do preparo do exame, com valor. Quem assistiu ao vídeo de azia vê o anúncio de consulta com horários.

Eu não mexo numa campanha em menos de 72 horas e olho o mês, não o dia. Eu reporto duas medidas lado a lado: conversa iniciada e segunda mensagem enviada. Só a primeira infla.

5 3 ângulos de criativo

Cada um filtra um paciente. Atenção sem filtro traz curioso, e curioso encarece a conversa.

Azia todo dia

"Azia que volta todo dia é queixa para consulta, não só para antiácido."

Vídeo do médico. Filtra quem se medica sozinho há meses.

Endoscopia sem susto

"Endoscopia: como é, quanto tempo dura e se dá para voltar ao trabalho no mesmo dia."

Reel com a rotina do exame, sem foto de paciente. Reduz o medo e responde o preço.

Assunto de mesa

"Tem paciente que sente todo dia e não fala: barriga inchada depois de comer. Eu falo."

Reel ou carrossel. Tira a vergonha e filtra quem convive com o sintoma.

6 5 dúvidas de paciente para virar conteúdo

1. "Gastrite é nervoso?"
2. "Refluxo tem cura ou é para a vida toda?"
3. "Endoscopia dói? Preciso de sedação?"
4. "Intolerância à lactose: preciso fazer exame?"
5. "Barriga inchada todo dia, o que pode ser?"

Cada dúvida vira um vídeo ou carrossel. Toda resposta com número ou critério precisa de fonte que você possa citar. Sem fonte, tira o número e fica o raciocínio.

7 O combinado com a recepção

Eu trabalho com 20 minutos como limite de resposta: quem tem dor costuma chamar mais de um consultório e fecha com quem responde primeiro e já oferece horário.

Quem responde | **Em quanto tempo** | **O que a IA pode fazer sozinha**

A primeira resposta, por escrito

Repetir o que a pessoa pediu, informar o valor e oferecer dois dias e horários. Cadastro e reserva vêm depois da escolha.

Pergunta inicial: "É um sintoma que você sente agora ou é uma consulta ou exame de rotina? Há quanto tempo?"

Urgência e encaixe

Dor abdominal forte, vômito com sangue, fezes pretas ou incapacidade de comer e beber: a recepção não marca. Orienta pronto-socorro.

Quem marca exame recebe o preparo por escrito na confirmação e um lembrete no dia anterior. Preparo mal explicado pode virar falta, e falta de exame é horário perdido.

Automático pode ser o aviso de recebimento, a pergunta inicial e o lembrete de horário. Preço, horário e qualquer orientação de saúde saem de uma pessoa ou de um texto que você já aprovou.

8 O que eu NÃO faria, pelo conselho

Base: Resolução CFM 2.336/2023, a vigente. Ela permite informar preço, forma de pagamento e desconto. Continua fora:

- Promessa de resultado, em qualquer forma.
- Antes e depois.
- Nota, estrela ou print de avaliação.
- Chamar alguém de especialista sem o RQE registrado.
- Escassez que não existe. "Últimos horários" só se a agenda estiver fechando de verdade.

Nesta especialidade, o risco mais comum

- Promessa de emagrecer, de desintoxicar ou de curar gastrite e refluxo.
- Antes e depois de barriga, de exame ou de dieta.
- Print de avaliação, com nota ou estrela, em anúncio.
- Colocar "gastroenterologista" no título sem o RQE. Sem ele, use "médico" e descreva a área em que atende.

Antes de subir qualquer anúncio, o texto passa por revisão. Este plano não substitui a leitura da resolução pelo responsável técnico.

E antes da conversa chegar?

O plano cuida do anúncio e da recepção. O Raio-X olha o passo anterior: como o seu consultório aparece hoje no Google e na IA. Leva poucos minutos.

Fazer o Raio-X do meu consultório